Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 7ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº **0005304-40.2023.8.17.2001**

AUTOR: MANUELA TAVORA DE SOUSA DOMINGUES

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

-

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.

- Contrato de seguro saúde anterior à lei 9.656 (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104153/lei-9656-98)/98 e não adaptado.

- O STF, no julgamento do RE 948.634 (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4928717)/RS, recurso com tema representativo submetido à Repercussão Geral, Tema 123, entendeu pela irretroatividade da Lei 9.656/1998, decidindo por sua não aplicação aos contratos firmados anteriormente à sua vigência e não adaptados.

- Enunciado 33, da i jornada de direito da saúde do CNJ, que recomenda aos magistrados a análise dos pareceres técnicos da agência nacional de saúde suplementar e da comissão nacional de incorporação de tecnologias no SUS (CONITEC) na prolatação de decisão.

- Atenção à lei 9.656/98 ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, RN nº 465, de 24/02/2021.

- Fornecimento de medicamentos não oncológicos - recusa amparada nas exceções do art. 10, VI, da lei 9.656/98; inciso VI do parágrafo único do art. 17 da RN nº 465, de 24/02/2021; parecer técnico nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021.

.

Vistos etc.

MANUELA TAVORA DE SOUSA DOMINGUES, qualificada, mediante advogado, ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, igualmente identificada.

Requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita e negando interesse na realização da audiência de conciliação ou mediação, expôs ser titular de contrato de assistência à saúde com a demandada, código de identificação nº 09003 8009 9118 0110, estando adimplente com suas obrigações contratuais.

Disse ser portadora de síndrome de Tourette, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e transtorno compulsivo (TOC), sofrendo com hiperatividade, inquietação, comprometimento da linguagem, baixa intenção comunicativa, sendo acompanhada, há 5 anos, pela Dra. Jadia Freitas – CRM 14925, tendo tentado diversas formas amenizar os sintomas da doença, tanto de forma medicamentosa, como com terapias.

Narrou haver o Dr. Gustavo Holanda, CRM/PE 21.131, especialista em neurologia pediátrica, em virtude do insucesso com as medicações anteriores, indicado como tratamento o uso de "*CANABIDIOL NUNATURE 17,18MG/ML (20 GOTAS AO DIA), ARISTAB (ARIPIPRAZOL) 10MG (MEIO COMPRIMIDO À NOITE), REVOC (FLUVOXAMINA) 100 MG (1 COMPRIMIDO À NOITE), RITALINA (METILFENIDATO) 10MG (2 COMPRIMIDOS AO DIA) E CANABIDIOL NUNATURE 17,18MG/ML (20 GOTAS AO DIA), ATENSINA (CLONIDINA) 0,1MG (MEIO COMPRIMIDO À NOITE)",* de uso contínuo por tempo indeterminado.

Disse haver solicitado à ré, por meio do ofício nº 49/NOVEMBRO/2022, a autorização para fornecimento dos remédios, sem ter recebido resposta

Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que a demandada seja compelida a custear integralmente o tratamento, na forma prescrita pelo especialista. No mérito, pediu confirmação da tutela e indenização por danos morais de R$ 20.000,00. Acostou documentos.

Ordem de emenda para: "a*) Retificar o valor atribuído à causa, incluindo o valor mensal do tratamento, devendo ser o valor da causa correspondente ao somatório dos pedidos; b) Juntar aos autos o contrato celebrado entre as partes ou comprovar sua requisição administrativa e a negativa de seu fornecimento; Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte autora para trazer seus comprovantes de rendimentos mensais atualizados do responsável, extratos de cartão de crédito, declaração de bens, cópia do imposto de renda e fatura de energia elétrica e de consumo de água, nos moldes do art. 99, §2, do CPC, após o que apreciarei o pleito de gratuidade da justiça*;" (id 124154685).

Manifestação da autora na peça de id 125576388, por meio da qual indicou ser o custo total do ano equivalente a R$ 10.495,08, negando ter cópia do instrumento de pacto firmado com a ré e retificando o valor atribuído à causa para R$ 30.495,08. Acostou documentos.

Decisão alterando o valor da causa para R$ 30.495,08, considerado como especificação do pedido, à falta de emenda, para fins dos arts. 322 e 324 do CPC, o período de um ano de fornecimento dos medicamentos, deferindo o pedido de gratuidade da justiça e indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (id 128616315).

Contestação aventando falta de pretensão resistida por não ter sido juntada prova de negativa de cobertura.

Alegou se tratar de contratou seguro saúde anterior à edição da Lei 9.656/98 e não adaptado.

Disse ser a recusa ao fornecimento dos medicamentos conduta respaldada na Lei Federal 9.656/98, nas Normas da ANS, e no contrato firmado entre as partes, sendo medicamentos de uso domiciliar.

Apontou que, mesmo tendo registo na ANVISA, não possui a parte direito ao custeio para tratar doença ao qual ele não se destina, fazendo uso de forma "off label". Invocou os enunciados formulados nas Jornadas De Direito Da Saúde Do Conselho Nacional De Justiça – CNJ, que versam sobre o tema: "*ENUNCIADO Nº 06 A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. ENUNCIADO Nº 26 É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental (Tema 990/STJ)".*

Asseverou que tratamento pleiteado se trata de despesa expressamente excluída do contrato de seguro saúde objeto da presente lide, devendo o pleito autoral ser julgado totalmente improcedente.

Refutou haver danos morais a indenizar. Pediu a improcedência dos pedidos autorais. Acostou documentos.

Intimação da parte autora para réplica e das partes para indicação de possibilidade de composição ou outras provas a produzir (id 141711246).

Réplica reafirmando os termos da inicial e peça negando ter provas a produzir.

Peça da ré negando ter provas a produzir.

É o relatório, passo à decisão.

No que concerne à arguição de falta de interesse de agir, por não haver a parte provado prévio requerimento administrativo ou tentado acordo em plataformas extrajudiciais de conciliação, rejeito tal alegação em nome do direito de acesso à Justiça pela inafastabilidade.

Cuida-se da hipótese de questão que dispensa dilação probatória, uma vez que os elementos presentes, inclusive a prova documental, já são suficientes para emitir a sentença.

CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656 (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104153/lei-9656-98)/98 E NÃO ADAPTADO:

O STF, na ADI 1931, havia decido pela não aplicação da Lei nº 9.656 (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104153/lei-9656-98)/98 aos contratos firmados anteriormente à sua vigência, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 10 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11332400/artigo-10-da-lei-n-9656-de-03-de-junho-de-1998), § 2º (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11332513/par%C3%A1grafo-2-artigo-10-da-lei-n-9656-de-03-de-junho-de-1998), e 35-E (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28001357/artigo-35e-da-lei-n-9656-de-03-de-junho-de-1998) da Lei 9.656 (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104153/lei-9656-98)/1998, bem como do art. 2º da Medida Provisória 2.177-44/2001, que modificou o referido diploma normativo, decisão transitada em julgado em 27/06/2018, pelo que, em diálogo de fontes, neste caso, caberia aplicação apenas do Código Civil e das normas aplicáveis antes da referida Lei.

Tal decisão foi revisitada, pois, homologada a desistência no Recurso Extraordinário nº 578.801, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a substituição daquele recurso pelo Recurso Extraordinário com Agravo nº 652.492 (fl. 162, DJ 31.8.2011) e, em 15/12/2015, foi admitido o Recurso Extraordinário para regular tramitação e julgamento da matéria.

O próprio STF, agora no julgamento do RE 948.634 (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4928717)/RS, novo recurso com tema representativo submetido à Repercussão Geral, Tema 123, revisitou o tema do julgamento sobre a aplicação da Lei 9.656/1998, chamada lei de plano de saúde, aos contratos anteriormente firmados, negando tal aplicação:

> *"O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 123 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Roberto Barroso. O Ministro Gilmar Mendes acompanhou o Relator com ressalvas. Foi fixada a seguinte tese: "**As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime**, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados". Não participou deste julgamento o Ministro Celso de Mello. Afirmou suspeição o Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 9.10.2020 a 19.10.2020.**[1]** (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20n%C3%A3o%20oncol%C3%B3gico%20-%20Canabidiol-%20NOVA%20RES.docx#_ftn1)* (DJ 18/11/25020).

Assim, aquele Tribunal Supremo reafirmou a inaplicabilidade da Lei 9.656/98 aos contratos anteriormente firmados, assim sua ementa:

> *"Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA.*
>
> *I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos.*
>
> *II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo.*
>
> *IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional.*
>
> *V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração.*
>
> *VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda.*
>
> *VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes.*

VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam.

IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF.

X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade.

XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora.

XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.

XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento." (RE 948.634/RS, DJ 18/11/25020).

O exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, relator, assim se posicionou:

> *"Sendo assim, por melhor que seja a intenção, não tenho como fugir à conclusão de que os fatos nascidos sob a égide da legislação anterior à Lei 9.656/1998, quando ocorrida a pactuação, estão selados como atos jurídicos perfeitos, de modo que o exame de cláusulas contratuais estipuladas entre as partes, os termos da apólice, cobertura e suas exclusões não devem submeter-se à legislação posterior a ponto de tornálos inócuos ou desvirtuar seu propósito.*
> *É dizer, não estou afirmando que os contratos de planos de saúde, caracterizados por sua longevidade, estejam absolutamente imunes a toda e qualquer inovação legislativa que se apresente, especialmente quanto a normas de ordem pública que possam atingir cláusulas contratuais sujeitas a condições ainda não implementadas, como, por exemplo, o futuro implemento de determinada faixa etária. Aqui, embora a contratação efetivamente tenha sido consumada em data anterior, a cláusula etária ainda não o foi.*
> *O que afirmo é que, nos termos do tema submetido à Sistemática da Repercussão Geral, e dentro de seus limites objetivos e subjetivos, a Lei 9.656/1998 não pode regular contratos anteriores à sua vigência, salvo quando a parte aderente tiver optado por sua adaptação ao novo regramento."*

Assim, acato o posicionamento, como deve ser, pois precedente submetido à Repercussão Geral, Tema 123, para entender como não cabível a aplicação da Lei 9.656/1998 ao contrato sob foco.

CASO CONCRETO

A jurisprudência pátria vem sofrendo para estabelecer decisões em casos de cobertura de procedimentos por contratos de assistência à saúde, pois, de um lado, há toda uma gama de direitos estabelecidos em favor da saúde, personalidade e consumidor, havendo, porém, a necessidade de preservação da viabilidade econômica das empresas que ofertam tais pactos e do equilíbrio das contraprestações.

Para tanto, este juízo tem se amparado das normas que lastram ambas as vertentes e das normativas do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), criado pela Lei 9.656/1998, e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - Autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, instituída pela Lei 9.961/00, para regulação e fiscalização das atividades que garantam assistência suplementar.

Ressalto que o Enunciado 33, da I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ, dispõe aos magistrados que atentem para os pareceres técnicos das agências reguladoras:

> "*ENUNCIADO N.º 33 Recomenda-se aos magistrados e membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e aos Advogados a análise dos pareceres técnicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar* e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec)** para auxiliar a prolatação de decisão ou a propositura da ação."*

As Diretrizes de Utilização (DUT) são regras e normas elaboradas pela Agência Nacional de Saúde (ANS) que servem para orientação e regulamentação do uso adequado de procedimento médicos e exames complementares, sendo descritas e baseadas em estudos médicos com a finalidade de utilização das novas tecnologias ou exames que realmente possam trazer benefícios para o paciente ou que auxiliem os médicos no diagnóstico de doenças.

Ressalto que o chamado Plano de Referência foi instituído pelo art. 10 da lei 9.656/98 como aquele com "*cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde (...)"* (redação da MP 2.177-44/2001).

Afere-se que mesmo o plano de referência não possui cobertura ilimitada, pois há exceções de cobertura no próprio artigo e em regulamentações da ANS.

O pedido foi de **fornecimento de medicamentos**, cabendo ser observado que mesmo o plano de referência não possui tal cobertura, havendo exceções de cobertura no próprio artigo e em regulamentações da ANS. Assim o art. 10 da lei 9.656/98:

> *"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, **exceto**: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)* (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1)
>
> *I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)* (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1)
>
> *II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;*
>
> *III - inseminação artificial;*
>
> *IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;*
>
> *V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;*

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm#art2) *(Vigência)* (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12880.htm#art3)

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2177-44.htm#art1)

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente."

Algumas dessas exceções constam do inciso VI do parágrafo único do art. 17 da RN nº 465, de 24/02/2021:

"Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.
Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:
(...)
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;

O PARECER TÉCNICO Nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021[2] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20n%C3%A3o%20oncol%C3%B3gico%20-%20Canabidiol-%20NOVA%20RES.docx#_ftn2), que trata dos medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, diz ser obrigatória a cobertura para:

"a) Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 18, inciso XI, da RN n.º 465/2021), respeitadas as Diretrizes de Utilização – DUT descritas nos itens 54 e 64, do Anexo II, da RN n.º 465/2021; e

b) Medicamentos utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, obedecidas as exigências previstas nos normativos vigentes da ANVISA e nas alíneas "d" e "g", do inciso II, do artigo 12, da Lei n.º 9.656/1998 c/c art. 13, da RN n.º 465/2021.

c) Medicamentos que eventualmente constem em contrato ou aditivo contratual acordado entre as partes."

No presente caso, **não se trata de pedido de fornecimento de medicação oncológica domiciliar**, mas de: "*CANABIDIOL NUNATURE 17,18MG/ML (20 GOTAS AO DIA), ARISTAB (ARIPIPRAZOL) 10MG (MEIO COMPRIMIDO À NOITE), REVOC (FLUVOXAMINA) 100 MG (1 COMPRIMIDO À NOITE), RITALINA (METILFENIDATO) 10MG (2 COMPRIMIDOS AO DIA) E CANABIDIOL NUNATURE 17,18MG/ML (20 GOTAS AO DIA), ATENSINA (CLONIDINA) 0,1MG (MEIO COMPRIMIDO À NOITE)",* não estando coberto pelo contrato firmado e nem constando no rol de procedimentos de cobertura obrigatória editado pela ANS (RN nº 465/2021), pelo que descabe cobertura, enquadrando-se, o presente pedido, na exceção do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, inciso VI do parágrafo único do art. 17 da RN 465/2021, além do PARECER TÉCNICO Nº 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, não sendo obrigatório seu fornecimento pelo plano de saúde.

Trago à luz jurisprudência pátria:

> *"APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, consoante disposição do artigo 3º, § 2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. 2.* ***As operadoras de saúde, salvo contratação que amplie o espectro de cobertura, detêm obrigação de cobrir medicamentos quando em uso hospitalar, mas não os de uso domiciliar, salvo os relativos a tratamentos antineoplásicos, caso em que ainda devem ser observados os protocolos e diretrizes da ANS. 3. No presente caso, o fármaco postulado para uso domiciliar não se configura como antineoplásico e há exclusão de cobertura expressamente prevista no contrato para o caso, sendo válida a negativa de cobertura operada****. 4. Válida a negativa, sem fundamento o abalo moral pleiteado e, julgada improcedente a demanda com inversão da sucumbência, prejudicado o pedido de majoração dos honorários da parte vencida. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E APELO DA PARTE RÉ PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075983320, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 28/03/2018). (TJ-RS - AC: 70075983320 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2018)"*
>
> *"DECISÃO (..) No caso dos autos, a narrativa exordial e a prescrição médica de ID nº 42959481, pág. 8 deixam claro o uso domiciliar do fármaco pleiteado (enoxaparina sódica). A bula do fármaco disponível no sítio eletrônico da ANVISA' enfatiza a modalidade irjetável do medicamento, o que não significa que seu uso deva se dar em ambiente hospitalar, em regime de internação. Além da própria pessoa poder aplicar o remédio, terceiros também o podem, como comumente ocorre em farmácias, por exemplo.* ***Em relação às obrigações contratuais firmadas entre as partes, há cláusula excludente de fornecimento de remédios de uso domiciliar (cláusula 8.1, item g, do contrato ? ID nº 47702266, pg. 10). Portanto, inexiste obrigação legal ou contratual da operadora de saúde ré financiar os medicamentos de uso domiciliar prescritos para a autora, devendo ser rejeitada a pretensão autoral, inclusive, em sede de antecipação de tutela, conforme decisão interlocutória proferida por este juízo ao ID nº 43154800.(...)*** *5. O Tribunal de origem - destinatário da prova - após a análise dos elementos informativos dos autos, assim concluiu: A controvérsia no caso sub judice, cinge-se à análise da obrigatoriedade do plano apelante em fornecer ou não, o o medicamento "enoxaparina sódica" (CLEXANE) à apelante, nos moldes da prescrição constante no relatório médico. De início, importante esclarecer que, consoante súmula 469 do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde", o que assegura que a interpretação das cláusulas contratuais devem ser feitas do modo mais favorável ao consumidor, conforme dispõe o art. 47 do CDC. No caso dos autos, verifico que a juíza a quo julgou improcedentes os pedidos sob o argumento de que o fármaco pleiteado (enoxaparina sódica) é de uso domiciliar, e "inexiste obrigação legal ou contratual da operadora de saúde ré financiar os medicamentos de uso domiciliar prescritos para a autora". Compulsando os autos, verifico que há laudos firmados pelos especialistas que acompanham o quadro clínico da apelante indicando especificamente, ante as particularidades do caso, a necessidade de que o tratamento ocorra por meio do fármaco "enoxaparina sódica - Clexane". (...) Não se pode olvidar que a preservação da vida se sobrepõe a qualquer outro interesse, e considerando que o medicamento em questão está amparado por justificativa e requisição médica, diante da gravidez de alto risco da autora/apelante e do histórico de 04 (quatro) abortos consecutivos (Id. 5444915 - Pág. 10), não há negar o fornecimento do medicamento pelo plano, independentemente de sua administração ser domiciliar ou ambulatorial, sob pena de sujeitá-la à risco de morte. Ademais, como objetivo precípuo dos contratos de seguro e assistência à saúde, está assegurar ao consumidor o tratamento, a segurança e o amparo necessários contra os riscos inerentes à sua saúde, e os arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º, do CDC, preveem a necessidade da adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor de não ficar desamparado de procedimento essencial à preservação de sua vida. Assim, ainda que exista cláusula contratual que exclua o fornecimento do referido fármaco, tal dispositivo seria considerado ilegal e abusivo por restringir a possibilidade de cura do usuário do plano,*

afrontando, ainda, o direto a vida previsto na Constituição Federal. (...) Verifica-se que o acórdão recorrido não está em harmonia com a atual jurisprudência do STJ sobre o tema. ***Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que: "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)****" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).* ***A orientação do STJ é no sentido de que: "A universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º, § 1º, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente****.".(REsp 1755866/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020).* ***Conforme consta na sentença, o medicamento vindicado na ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim. Sendo assim, o não fornecimento do fármaco, não pode ser considerado ilegal e abusivo, segundo entendimento desta Corte****. 6. Ante o exposto, conheço do agravo interno para reconsiderar a decisão de fls. 705-707 e-STJ, conheço do agravo em recurso especial a fim de dar provimento ao recurso especial para, restabelecendo o decidido na sentença, julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem, observada eventual gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2022. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (STJ - AgInt no AREsp: 1952340 RN 2021/0245500-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 08/02/2022)"* (grifos para destacar)

Ante o exposto, **julgo improcedentes** os pedidos.

Condeno a parte demandante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao procurador adversário, com base no art. 85, § 2°, do CPC, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, que suspendo conforme art. 98, §5°, CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos.

Recife, 29 de setembro de 2023.

IASMINA ROCHA

Juíza de Direito

[1] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20n%C3%A3o%20oncol%C3%B3gico%20-%20Canabidiol-%20NOVA%20RES.docx#_ftnref1) Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4928717&numeroProcesso=948634&classeProcesso=RE&numeroTema=123 (http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4928717&numeroProcesso=948634&classeProcesso=RE&numeroTema=123)>. Acesso em 02/04/2021.

[2] (file:///C:/OS5829-IASMINA/Documentos/NOVO%20CPC/SENTEN%C3%87AS/Senten%C3%A7a%20-%20Plano%20Sa%C3%BAde%20-%20Medicamento%20n%C3%A3o%20oncol%C3%B3gico%20-%20Canabidiol-%20NOVA%20RES.docx#_ftnref2) https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2020/parecer_tecnico_no_20_2021_medicamentos_para_tratamento_domiciliar.pdf (https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2020/parecer_tecnico_no_20_2021_medicamentos_para_tratamento_domiciliar.pdf)> ACESSO EM 02/08/2023.

Assinado eletronicamente por: IASMINA ROCHA
29/09/2023 08:34:26
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 146295386

23092908342666600000142881564

IMPRIMIR GERAR PDF